STAKEHOLDER ANALYSIS DAN POWER–INTEREST GRID
Sistem Informasi Klinik Terintegrasi
Studi Kasus: Klinik Sehat Bersama

Nama : Iis Febriani

Nim : 2507074

Mata Kuliah : Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

1. Gambaran Singkat Studi Kasus

Klinik Sehat Bersama adalah klinik swasta yang melayani pemeriksaan umum, konsultasi dokter, tindakan medis, dan pelayanan obat. Proses pelayanan masih dilakukan secara manual dan memakai beberapa aplikasi yang tidak saling terintegrasi, sehingga pelayanan kurang efisien, pencarian riwayat pasien membutuhkan waktu, dan laporan operasional disusun terpisah. Manajemen berencana mengembangkan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi yang mencakup pendaftaran, data pasien, rekam medis, pemeriksaan, tindakan, resep dan obat, pembayaran, serta laporan manajemen. Proyek dibatasi oleh anggaran dan waktu, dan data pasien harus dijaga keamanannya.

2. Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Kepentingan / Peran
1	Pemilik Klinik	Pemilik klinik menginginkan sistem yang meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan bisnis klinik.
2	Kepala Klinik	Memimpin proyek; membutuhkan sistem terintegrasi serta informasi untuk pengambilan keputusan.
3	Divisi IT	Bertanggung jawab atas implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem.
4	Dokter	Membutuhkan akses cepat ke riwayat kesehatan pasien dan hasil pemeriksaan.
5	Vendor Pengembang	Bertanggung jawab membangun dan menyesuaikan sistem berdasarkan kebutuhan klinik.
6	Apoteker	Membutuhkan informasi resep yang akurat dan informasi stok obat yang selalu diperbarui.
7	Petugas Kasir/Keuangan	Membutuhkan sistem yang dapat mencatat pembayaran dan menghasilkan laporan transaksi secara akurat.
8	Petugas Pendaftaran	Membutuhkan proses pendaftaran yang lebih cepat agar antrean pasien berkurang.
9	Perawat	Membutuhkan sistem yang mudah digunakan untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien.

No	Stakeholder	Kepentingan / Peran
10	Pasien	Mengharapkan pendaftaran dan pelayanan lebih cepat serta informasi yang lebih akurat.
11	Pemasok Obat	Berkepentingan pada pemesanan obat; terdampak tidak langsung melalui informasi stok yang lebih akurat.

3. Penilaian Power dan Interest beserta Alasan.

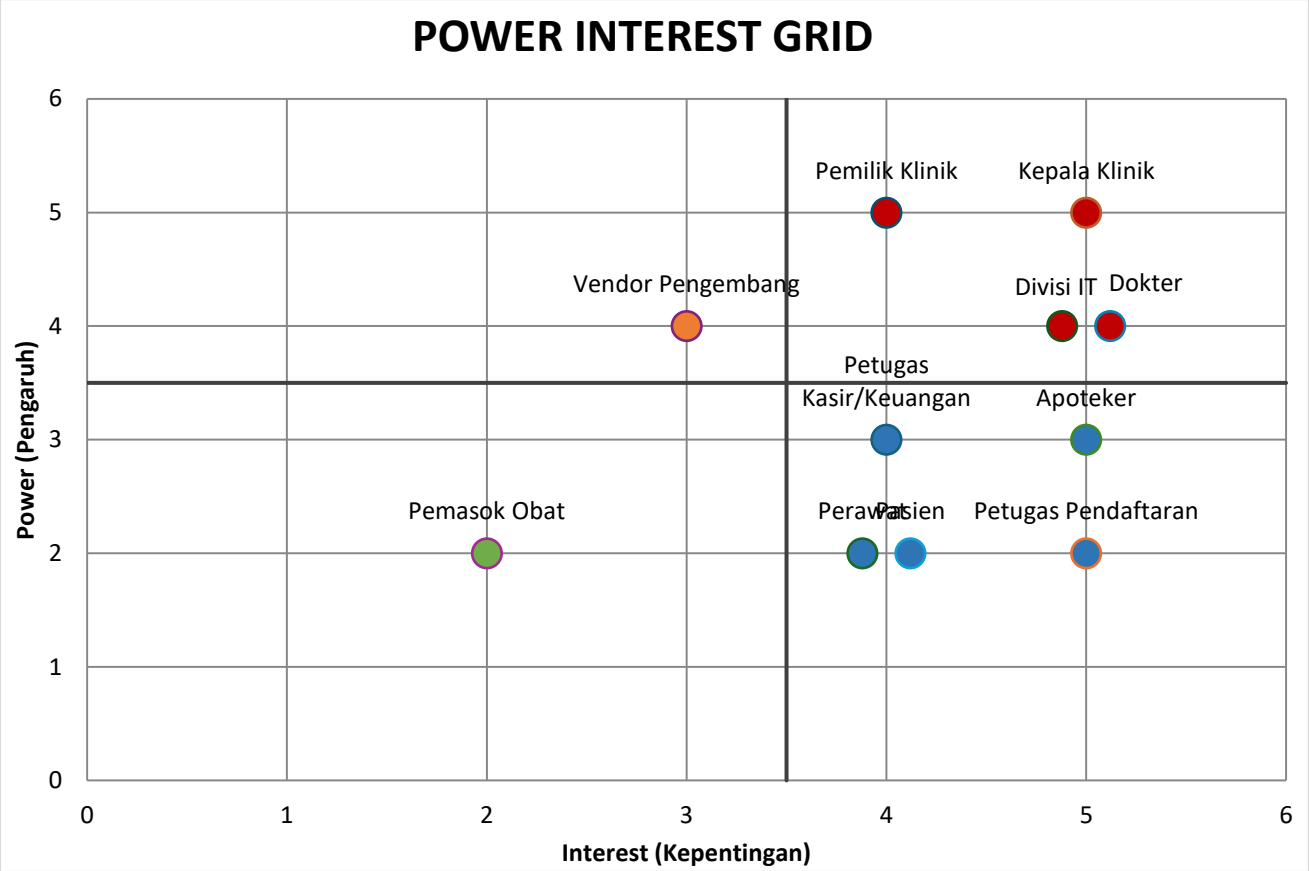
No	Stakeholder	Power	Interest	Alasan / Argumentasi
1	Pemilik Klinik	5	4	Power: Pemilik adalah pemodal dan pemberi mandat proyek; dapat menghentikan atau melanjutkan proyek. Interest: Hasil sistem berdampak langsung pada kualitas layanan dan pertumbuhan bisnisnya, tetapi ia tidak terlibat dalam operasional harian.
2	Kepala Klinik	5	5	Power: Memimpin proyek, menyetujui anggaran, jadwal, dan lingkup; penentu utama keberhasilan proyek. Interest: Sangat bergantung pada sistem untuk integrasi layanan dan data pengambilan keputusan.
3	Divisi IT	4	5	Power: Menentukan arsitektur, keamanan, dan integrasi sehingga sangat memengaruhi jalannya proyek, namun keputusan akhir tetap di manajemen. Interest: Menanggung implementasi dan pemeliharaan sistem; sangat peduli pada hasil.
4	Dokter	4	5	Power: Dokter adalah pengguna kunci dan tenaga profesional; penolakan atau ketidakpuasan dokter dapat membuat sistem gagal diadopsi. Interest: Pekerjaannya (akses rekam medis, hasil pemeriksaan) sangat bergantung pada sistem.
5	Vendor Pengembang	4	3	Power: Memegang kendali teknis pembangunan dan jadwal; keterlambatan atau kualitas buruk memengaruhi proyek, tetapi bukan penentu kebijakan klinik. Interest: Kepentingan lebih pada kontrak dan penyelesaian proyek, bukan pada penggunaan harian.
6	Apoteker	3	5	Power: Pengaruh sedang: masukan soal resep dan stok menentukan fitur farmasi, namun tidak memutuskan arah proyek. Interest: Kesalahan data resep/stok berdampak langsung pada pekerjaan dan keselamatan pasien.
7	Petugas Kasir/Keuangan	3	4	Power: Pengaruh sedang: masukan memengaruhi modul pembayaran dan laporan, tetapi bukan pengambil keputusan. Interest: Akurasi transaksi dan laporan keuangan menjadi tanggung jawab langsung mereka.
8	Petugas Pendaftaran	2	5	Power: Pengaruh rendah: hanya memberi masukan alur pendaftaran, tidak ikut memutuskan. Interest: Pengguna harian paling intensif; kecepatan pendaftaran langsung memengaruhi pekerjaan dan antrean.

No	Stakeholder	Power	Interest	Alasan / Argumentasi
9	Perawat	2	4	Power: Pengaruh rendah: berperan sebagai pengguna, bukan pengambil keputusan. Interest: Mengandalkan sistem setiap hari untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien.
10	Pasien	2	4	Power: Pengaruh rendah: tidak terlibat dalam keputusan proyek, tetapi pengalaman dan keluhan pasien tetap menjadi tolok ukur layanan. Interest: Berkepentingan pada proses yang cepat dan informasi akurat, namun tidak bergantung penuh pada sistem.
11	Pemasok Obat	2	2	Power: Pengaruh rendah: tidak berpengaruh pada keputusan proyek. Interest: Kepentingan rendah: hanya terdampak tidak langsung lewat pola pemesanan stok.

4. Stakeholder Map

No	Stakeholder	Power	Interest	Posisi pada Grid
1	Pemilik Klinik	5	4	Kelola secara dekat (Manage Closely)
2	Kepala Klinik	5	5	Kelola secara dekat (Manage Closely)
3	Divisi IT	4	5	Kelola secara dekat (Manage Closely)
4	Dokter	4	5	Kelola secara dekat (Manage Closely)
5	Vendor Pengembang	4	3	Jaga kepuasannya (Keep Satisfied)
6	Apoteker	3	5	Libatkan / komunikasi rutin (Keep Informed)
7	Petugas Kasir/Keuangan	3	4	Libatkan / komunikasi rutin (Keep Informed)
8	Petugas Pendaftaran	2	5	Libatkan / komunikasi rutin (Keep Informed)
9	Perawat	2	4	Libatkan / komunikasi rutin (Keep Informed)
10	Pasien	2	4	Libatkan / komunikasi rutin (Keep Informed)
11	Pemasok Obat	2	2	Monitor (Minimum Effort)

5. Power–Interest Grid



Gambar 1. Power–Interest Grid Sistem Informasi Klinik Terintegrasi.

6. Strategi Pengelolaan Stakeholder

No	Stakeholder	Kategori	Strategi Komunikasi
1	Pemilik Klinik	Kelola secara dekat	Laporan progres dan nilai bisnis secara berkala; persetujuan keputusan strategis.
2	Kepala Klinik	Kelola secara dekat	Rapat koordinasi mingguan, dashboard progres, keputusan anggaran dan lingkup.
3	Divisi IT	Kelola secara dekat	Koordinasi harian/mingguan dengan tim proyek; libatkan sejak desain arsitektur dan keamanan.
4	Dokter	Kelola secara dekat	Wawancara kebutuhan, demo prototipe, pelatihan khusus, dan jalur umpan balik cepat.
5	Vendor Pengembang	Jaga kepuasannya	Kontrak dan SLA jelas, pantau jadwal, review hasil per sprint/milestone.

No	Stakeholder	Kategori	Strategi Komunikasi
6	Apoteker	Libatkan / komunikasi rutin	Sesi kebutuhan modul resep dan stok, uji coba, dan pelatihan.
7	Petugas Kasir/Keuangan	Libatkan / komunikasi rutin	Validasi format laporan transaksi, uji coba pembayaran, dan pelatihan.
8	Petugas Pendaftaran	Libatkan / komunikasi rutin	Uji coba alur pendaftaran, pelatihan, panduan singkat, dan dukungan saat go-live.
9	Perawat	Libatkan / komunikasi rutin	Pelatihan, panduan penggunaan sederhana, dan kanal umpan balik.
10	Pasien	Libatkan / komunikasi rutin	Informasi perubahan layanan, petunjuk pendaftaran baru, dan survei kepuasan.
11	Pemasok Obat	Monitor	Pantau kebutuhan pemesanan; informasikan bila ada perubahan proses stok.

7. Penjelasan Kategori Stakeholder

1. **Dikelola secara dekat (High Power – High Interest)**
   Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT, dan Dokter. Mereka menentukan arah dan keberhasilan proyek sekaligus sangat peduli pada hasilnya, sehingga perlu dilibatkan dalam keputusan penting dan dikomunikasikan secara intensif.

2. **Dijaga kepuasannya (High Power – Low Interest)**
   Vendor Pengembang. Ia memegang kendali teknis dan jadwal, tetapi kepentingannya terbatas pada penyelesaian kontrak. Kepuasannya dijaga melalui kontrak/SLA yang jelas dan komunikasi yang tidak berlebihan.

3. **Dilibatkan melalui komunikasi rutin (Low Power – High Interest)**
   Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, Petugas Pendaftaran, Perawat, dan Pasien. Mereka pengguna sistem yang paling terdampak; keterlibatan melalui uji coba, pelatihan, dan umpan balik penting agar sistem mudah diadopsi.

4. **Cukup dimonitor (Low Power – Low Interest)**
   Pemasok Obat. Pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek rendah sehingga cukup dipantau dan diberi informasi bila ada perubahan.